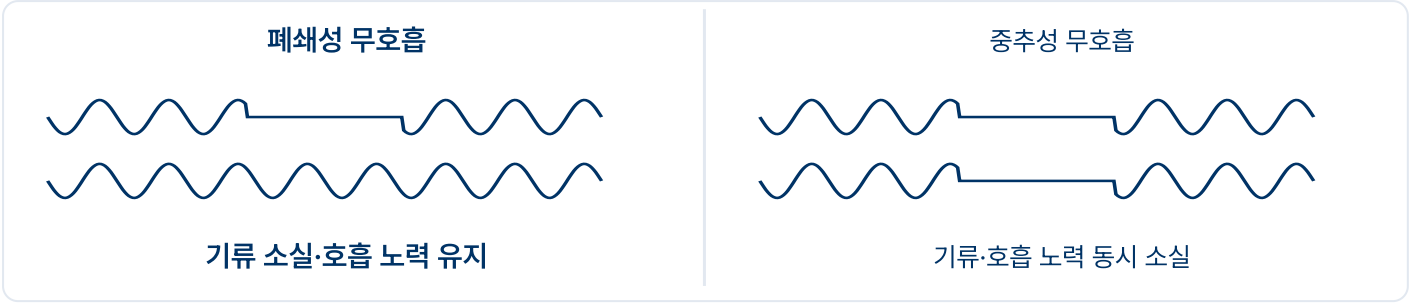
OSA로만 해석하면 안 되는 수면검사

기류와 호흡 노력을 함께 본다

무호흡–저호흡 지수만으로 모든 사건을 폐쇄성 수면무호흡(OSA)으로 해석하지 않는다. 기류, 흉복부 호흡 노력, 이산화탄소와 호흡 패턴을 함께 평가한다.

핵심 판단의 흐름



기류와 호흡 노력으로 감별

관찰	강의의 해석
폐쇄성 무호흡	기류가 멎어도 흉부·복부 움직임이 유지된다. 각성 후 호흡이 재개될 수 있다.
중추성 무호흡	기류 소실과 함께 흉부·복부 움직임도 멎는다.
저호흡 분류	코골이·기류제한·역설적 흉복부 운동 중 하나라도 있으면 폐쇄성 저호흡. 셋 다 없으면 중추성 저호흡으로 구분한다.

저환기(hypoventilation) 수치 기준

대상	교재의 이산화탄소 조건
성인 기준 ①	동맥혈 PCO_2 >55 mmHg가 ≥10분 지속.
성인 기준 ②	동맥혈 PCO_2가 ≥10 mmHg 상승해 >50 mmHg가 된 상태가 ≥10분 지속. ① 또는 ②로 제시한다.
소아	동맥혈 PCO_2 >50 mmHg인 시간이 총 수면시간의 >25%.

진료실에서 기억할 점

무호흡은 일회호흡량 ≥90% 감소·≥10초로 제시했다. 소아의 시간 기준은 호흡주기 ≥2회다. 체인스토크스 호흡의 진단 조합은 다음 쪽에서 확인한다.

체인스토크스 호흡의 진단 조합

Cheyne–Stokes breathing — 교재 조건을 함께 적용

교재의 진단식은 (A 또는 B) + C + D다. C의 세 가지 수면다원검사 조건은 모두 충족해야 한다.

핵심 판단의 흐름



ICSD 3 — 교재의 조합

구분	충족할 내용
A 또는 B	A: 졸림·입면/수면유지 곤란·잦은 각성·비회복성 수면·숨차서 깸·코골이·목격 무호흡 중 ≥1개. 또는 B: 심방세동/조동, 심부전, 신경계 질환.
C: 세 조건 모두	중추성 무호흡 및/또는 저호흡 ≥5회/시간 + 전체 무호흡·저호흡의 >50%가 중추성 + 체인스토크스 호흡.
D	현재의 다른 수면장애, 약물 사용 또는 물질사용장애로 더 잘 설명되지 않음.

체인스토크스 호흡 패턴의 채점 조건

구분	교재의 조건
연속성·주기	중추성 무호흡 및/또는 저호흡이 ≥3회 연속되고, 사이의 호흡진폭이 점증·점감. 주기 길이는 ≥40초.
빈도·관찰시간	최소 2시간 관찰 중 점증·점감 패턴을 동반한 중추성 무호흡 및/또는 저호흡이 ≥5회/시간.

진료실에서 기억할 점

중추성 사건 빈도 ≥5회/시간, 전체 사건 중 중추성 비율 >50%, 체인스토크스 호흡을 모두 충족해야 C에 해당한다. A 또는 B, C, D의 조합을 함께 적용한다.